

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DEL TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE ESTREPTOCOCCO BETAHEMOLÍTICO DEL GRUPO A EN EXUDADO FARINGOAMIGDALAR

(Resumen de la píldora formativa realizada para la implantación del test rápido de detección de antígeno del estreptococo Grupo A en toda la población, MOOC-EASP 2021. Disponible en: <https://www.easp.es/project/implantacion-del-test-rapido-de-deteccion-de-antigeno-de-estreptococo-grupo-a-en-mayores-de-14-anos/>)

La faringoamigdalitis aguda (FAA) es uno de los motivos asistenciales más frecuentes en Atención Primaria y una de las razones más habituales por las que se prescriben antibióticos. Sin embargo, en el 40-80% de los casos en niños y en el 80-90% de los casos en adultos, es de etiología vírica. El porcentaje de casos por estreptococo beta hemolítico del grupo A (EBHGA) o *Streptococcus pyogenes* (única situación que requeriría tratamiento antibiótico), se estima en: 5-15% en adultos, 30-40% en niños 3-13 años; 5-10% en niños 2-3 años; y 3-7% en niños menores de 2 años.

Criterios de Centor/McIsaac (puntos)

- Antecedente o presencia de fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (+1)
- Exudado faringoamigdalar (+1)
- Adenopatías laterocervicales dolorosas (+1)
- Ausencia de tos (+1)
- Edad: 3-14 años (+1); >45 (-1); resto (0)

Es difícil diferenciar clínicamente la etiología vírica o bacteriana de la FAA. El patrón estándar para el diagnóstico sigue siendo el **cultivo faríngeo**, pero presenta limitaciones importantes: demora de 24-48 horas en el resultado; no permite distinguir entre infección aguda y estado portador. En la práctica habitual se utilizan **criterios clínicos** para identificar los pacientes con mayor probabilidad de infección por EBHGA. Los más utilizados

son los **criterios de Centor/McIsaac** aunque, debido a su baja sensibilidad y especificidad, no son un buen método para establecer la etiología estreptocócica: hasta un 65% de las FAA virales cursan con exudado amigdalar (F+); en un 30% de los casos de origen bacteriano no hay exudado (F-). El criterio con mayor valor predictivo positivo es la ausencia de tos (y/o la presencia de artromialgias, cefalea o exantema, que orientan a una etiología vírica). Por otra parte, en más del 50% de los casos con 4 criterios, la etiología es viral (F+).

Indicación del test de diagnóstico rápido

Las pruebas de diagnóstico rápido son sencillas y presentan actualmente una sensibilidad y una especificidad, superiores al 90% y un valor predictivo negativo por encima del 95% cuando se utilizan en **pacientes con dos o más criterios** de Centor y con una buena técnica de recogida.

En **mayores de 3 años**, con 3 o más puntos en la escala de Centor/McIsaac se indica la realización del test.

En **niños menores de 3 años**, al ser muy común la etiología viral y con una alta prevalencia de estado portador, la positividad de la prueba carece de significado. En menores de 3 años que presentan 3 o más puntos en la escala de Centor/McIsaac, sólo estaría indicada la realización del test si existen otros criterios: brote comunitario por EBHGA, paroniquia, impétigo, lengua en frambuesa, petequias en paladar o rash escarlatíniforme.

El test no es útil en FAA reiteradas tratadas con antibióticos, ya que puede dar falsos positivos por la presencia de restos bacterianos.

Indicación del test rápido (tratamiento si test positivo)

En personas de 3 o más años:

- ≥ 3 puntos escala Centor/McIsaac.

En menores de 3 años, considerar si:

- ≥ 3 puntos+ criterio adicional:
 - Brote comunitario por EBHGA.
 - Paroniquia.
 - Impétigo.
 - Lengua en frambuesa, petequias en paladar.
 - Rash escarlatíniforme.

(En presencia de síntomas virales: no indicado realizar test)

No indicación del test rápido

- 0-2 puntos escala Centor/McIsaac: no indicación de test ni de antibiótico.
- Niños <3 años con ≥ 3 criterios sin ningún criterio adicional (ver tabla anterior).
- Toma reciente de antibióticos (<1 mes)
- Paciente inmunodeprimido (tratar)
- Antecedentes personales de fiebre reumática (tratar)
- Brote comunitario por EBHGA (tratar)
- Absceso periamigdalino (tratar)

Adquisición del test diagnóstico por SIGLO

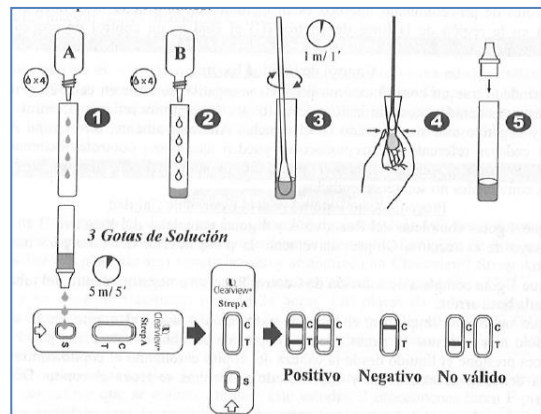
Nombre: Estreptococo A (*S. pyogenes*) prueba rápida-GC.

Genérico de Centro: A59165 (caja de 25 unidades).

Técnica diagnóstica

(Ver vídeo demostrativo en la píldora formativa).

- Tomar la muestra con una torunda estéril frotando las amígdalas y/o la pared posterior de la faringe del paciente si el paciente está amigdalectomizado. Es necesario evitar el contacto con los dientes, las encías, la lengua o la mejilla.
- Seguir las instrucciones de uso:
 - Agregar 4 gotas del reactivo A al cubilete de extracción.
 - Agregar 4 gotas del reactivo B y mezclar soluciones.
 - Introducir inmediatamente la torunda con el frotis en el cubilete y mezclar la solución, girando la torunda 10 veces. Dejar reposar durante 1 minuto.
 - Extraer la torunda, presionando con los dedos su cabezal para exprimir la mayor cantidad de líquido posible. Tapar el tubo con el tapón gotero.
 - Agregar 3 gotas de la solución en la celdilla de la muestra del kit (S) y cronometrar. Los resultados se leen a los 5 minutos, aunque, si es positivo para EBHGA, se puede visualizar antes. No leer después de 10 minutos.
- Importante:** Usar guantes para manipular la muestra y desechar la torunda y tiras como residuos biológicos.



Lectura

Resultado negativo: sólo aparece la línea de control.

Resultado positivo: cualquier línea de color azul junto a la línea de control.

Resultado no válido: no aparece línea de control o el color de fondo imposibilita la lectura de la línea de control.

Sistema de registro del test en historia clínica electrónica (DIRAYA)



Para la mecanización del resultado del test y como ayuda a la toma de decisiones clínicas existe un sistema de registro en la historia clínica del paciente.

El registro se puede realizar en un formulario que incorpora: los criterios de Centor/McIsaac con su ponderación por edades, el resultado del test rápido y una ayuda para la prescripción de antibiótico en caso de que se requiera.

Acceso a la guía rápida y vídeo explicativo:

<https://ficheros.juntadeandalucia.es/s/ruYyr956dVc5yYy>.

Grupo de trabajo

Ainhoa Mestraitua Vázquez. Médico de Familia. Distrito Huelva Costa-Condado Campiña.

M^a Dolores Pérez Pacheco. Farmacéutica de Atención Primaria AGS Jerez Costa Noroeste.

José Murcia García. Pediatra Atención Primaria. Distrito Jaén.

Walter Alfredo Goycochea Valdivia. Pediatra Hospital. HHUU Virgen del Rocío.

Carmen Serrano Martino. Laboratorio de Microbiología. H.U. Valme.

María Dolores Rojo. Laboratorio de Microbiología H.U. Regional de Málaga.

Joaquín Garrucho Moreno. Servicio de Coordinación. Sistemas de Información del SAS.

Rocío Fernández Urrusuno. Coordinadora Científico-Técnica PROA Andalucía. D^o Gral. Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

En nombre del Grupo Autonómico PROA.